

제 7장 산후풍의 관련병증

1절 산후풍의 개술

1. 정의

- 현재까지 산후풍의 대표적인 정의

- 1) 혈도증(血道症): 갱년기 장애와 유사한 자율신경증후군
(내분비성, 심인성)
- 2) 산후 해산독(解産毒)
- 3) 산후 편신등통(遍身疼痛): 류머티즘성의 관절 및 근육통

산후풍의 협의, 광의

- 1) 광의: 부인에게만 볼 수 있는 갱년기 등에 나타나는氣鬱의 자율신경 장애증후군과 腎虛로 인한 관절질환을 포함시키는 증후군
- 2) 협의: 산후조리를 잘못하여 나타나는 관절질환 및 근육통(=산후신통)
- 자율신경장애가 이학적 검사상으로 이상이 나타나지 않기에 정신적 문제처럼 보이기도 함

2. 용어의 의미

- 1) 산후: 정상분만 뿐만 아니라 유조산을 포함
- 2) 풍: 바람이 뼈속에 든 것 같은 느낌, 바람처럼 이리저리 옮겨 다님
감기든 것 같다, 열나고 땀난다
- 한열왕래 증상이 나타날 수도 있는데 이럴 때 기본적으로는 따뜻하게 해주는 게 좋음

3) 풍의 성상: 風 -> 疼痛, 痺證, 麻木의 의미

- 관절의 통증 (손, 발목, 무릎, 팔꿈치, 어깨, 환도, 허리 등)
- 저린감 (절절함, 먹먹함)
- 시린감 (국소, 전신, 가슴, 치아, 화하다, 시리다)

3. 육로

1) 개념: 산후풍과 유사한 증상, 산후노상과다

2) 원인: 산후 한달 안쪽에는 몸을 쓰지 말아야 하는데 다음과 같이 할 경우 발생

- ① 칠정노권이 심함 ② 일(ex. 바느질)을 많이 함
- ③ 생냉지물을 많이 먹음 ④ 풍한사 감촉

3) 치료: 십전대보탕 去 천궁 加 속단 우슬 별갑 상기생 도인 저신

4. 산후제반증상에 대한 문진표

계통	증상
신경정신계 (14%)	두통, 현훈, 수면장애, 우울감
순환기계 (23%) -> 가장 많이 호소	산욕열의 지속, 오한, 자한, 도한
호흡기계 (7%)	감모 증상
소화기계 (10%)	구갈, 다음, 식욕부진, 소화불량, 오심, 구토, 변비, 설사
골관절계	관절비통
비뇨기계	소변빈삭, 요실금, 소변불통
생식기계 (23%)	절개 및 봉합부위 불편, 하복통, 하혈, 오로불지, 월경변화
기타	탈모, 피부, 항문의 증상

산후풍 관련 논문

- 순환기계(23%), 생식기계(23%) 증상을 가장 많이 호소
- 개별적으로 가장 호소하는 증상은 절개 부위, 수술 부위의 불편감 혹은 회음부 불편감, 한출 증가
- 관절비통은 요통(33%) -> 무릎(25%) -> 손목 순 (꼭 큰 관절에서만 다발하는 것이 아님)
- 겨울철 多 (여름철 호발은 냉방의 영향)
- 주요 원인: 산후 과로 (30%)
- 출산직후 한약복용한 경우 -> 산후 관절증상 발생률 ↓
- 임신중 체중증가 ↑, 연령 ↑ -> 산후 관절증상 발생률 ↑
- 출산하고 發汗한 경우 산후 관절증상 많이 발생

산후 증상 발생 요인 관련 논문

- ① 산후 관절증상은 출산 직후 한약복용 한 경우 가장 낮음
- ② 임신 중 체중증가가 많을수록 산후 관절 증상 발생률 높음
- ③ 연령이 증가할수록 산후증상 발생률 높음
- ④ 출산 후 의식적인 발한 한 경우 산후 관절 증상 발생률 높음
- ⑤ 생식 보조 요법 받은 산모는 자연임신군보다 산후 증상 발생률 높음 (이건 일반화가 어렵긴 하지만, 과배란 유도를 통해 난소에 부하를 많이 걸어버린 경우에는 이럴 확률이 높다고 추측 가능)

문헌상 산후풍의 인식

- 포함관계: 산후병 >> 산후풍 ≥ 산후편신동통
 - 산후풍 = 산후편신동통 (최근 증례논문의 경향)
- (or/and) + 전신증상

(or/and) + 정신신경편증상

5. 산후편신동통 유발기전

- 1) 호르몬: Relaxin, E, P, Elastin 증가 -> 관절 인대섬유질 연화
- 2) 역학적 기전: 임신부 무게중심 이동 -> 척추전만, 골반전방경사, 두부 후방 이동
- 3) 혈관계: 혈량증가로 부종, 하대정맥 압박 -> 신경조직과 척추의 저산소증
- 4) 임신 체중 증가: 허리, 무릎, 발목의 관절에 부담
- 5) 선택위 분만자세: 허리와 천장관절에 통증
- 6) 자연분만시 골반관절의 과도한 견인: 치골결합 분리시켜서 분만 후 치골부 통증의 원인
- 7) 육아, 가사일 및 수유: 팔과 손의 과도한 사용

기타 산후에 동반 가능한 질환들

- ① 내분비질환 : 갑상선 기능 저하증, 쉬한증후군
- ② 자가면역 질환 : 류마티스 관절염
- ③ 신체화 증상 (심신증)
- ④ 자율신경 기능 이상

6. 산후풍의 증상 종합

- 통증 발현될 때 여러 관절에 다발성으로 발생
- 환자 자신만이 이 증상을 느끼고, 주변에 이해받지 못해 답답해하며, 나올 수 있을지 불안감 호소

동통 증상	전신 및 편측동통, 견항배부 견인통, 배통, 요통,
-------	------------------------------

	천미관절통, 상지관절통, 하지관절통, 소족비, 치골부통, 서혜부통, 소복통
전신 증상	무기력, 한출, 오한, 발열, 부종, 안혼이명, 호흡곤란, 오심구역, 식욕부진, 소화불량, 대소변이상, 대 하, 월경이상, 수족냉, 둔마감
정신신경 증상	두통, 현훈, 심계정중, 건망, 흥민, 불면, 불안, 다몽, 우울

7. 진단

- 통증부위별 검사: Finkelstein's sign(드퀘르뱅 증후군), Tinel's sign, Phalen, Allen test, Patrick's test
- Test - 그 외 : 혈액학적 검사, 내분비검사, X선검사 등

산후에 동반 가능한 질환들

- 드퀘르뱅 증후군
- 환도선다
- 기타 산후에 동반 가능한 질환들

- ① Endocrine - Hypothyroidism, Sheehan syndrome
- ② Autoimmune - RA
- ③ Somatoform disorder - body language
- ④ Autonomic dysfunction

8. 치료

- 血虛, 血瘀, 血風, 腎虛를 주요 병인 병기로 설정
+) 濕熱이나 挫閃傷, 氣鬱 등을 추가함

- 산후풍 환자를 진료할 때 산모의 신체 상태와 더불어 정서적 문제 파악과 지지에 유의

9. 유의점

- 출산 직후 급격한 내분비 변화와 육아에 대한 부담감, 가사노동으로 피로·스트레스에 내성 저하
- 다양한 정도의 우울감 느낄 수 있음
- 산후풍 환자 진료 시 산모의 신체 상태와 더불어 정서적 문제의 파악과 지지에 유의

2절 산후신통

1. 개술

정의	- 산욕기에 나타나는 관절이나 肢體痠楚, 疼痛, 麻木, 重着 등의 경우
원인질환	- 산과적 마비, 외슬와신경이 지배하는 근육의 마비 - 혈전성정맥염, 좌골신경통, 다발성신경염, 치골연합분리 - 수분저류 등으로 인해 말초신경의 압박과 신장에 의한 장애 발생 - 기타 당뇨병, 갑상선질환, 뇌하수체기능저하 - 중추신경 병증, 자율신경실조, 심신증 등
진단	- 산욕기간에 지체관절의 동통, 마목, 중착이 나타나면 신후신통 진단 - 시간적으로 산욕기에 다발하고 만약 치료할 시기를 놓

	치거나 잘못 치료하면 이후에도 지속됨
병인병기	- 산후 氣血虛弱하고 虛損이 未復하여 허한 틈을 타 사기가 인체 침입 - 기혈응체되거나 경맥이 失養하여 지체에 관절동통

골반관절의 분리 (Pelvic joint seperation)

- 분만시 치골결합부 또는 천장관절연골결합부의 분리가 발생하여 현저한 통증 및 운동장애를 초래
- 빈도: 1 in 30000 분만

치골결합분리의 기준

- 정상: 남성 - 2.88 / 여성 - 3.24

2. 변증론치

- 치료: 養血活血, 通絡止痛
- 일반적인 痺症과 차이점: 기혈이 俱虛하므로 비록 외감을 겸하여도 기혈조리하는 것을 위주
- 養血 위주로 한다. 준열한 風藥을 투여해서는 안 됨

산후신통의 한의학적 병인

혈허	전신 시큰거림, 마비감, 현훈, 경계	
	양혈익기 온경통락	항기계지오물탕, 사물탕, 팔진탕, 진교기생탕
외감	굴신 원할 X, 통증 부위 이동, 동통극렬	
	양혈거풍 산한제습	독활기생탕, 진통산, 오적산(마황 빼고)

신허	요슬산연, 현훈, 이명, 야뇨	
	보신 강요 장근골	양영장신탕
혈어	동통이 심하고 만지면 심해짐	
	양혈활혈 화어통락	생화탕, 사물탕, 신통축어탕

- 상지통에는 상지 / 하지통에는 우슬 / 관절통에는 송절 가감
- 통증이 심하고 지체가 굴신불리하면 해풍등, 신근초
- 통증이 침으로 찌르는 것 같으면 강황, 몰약, 유향 등 가미
- 계혈등: 활혈통락 + 보혈작용 -> 허증 실증 모두에 사용

3절 산후요통

1. 개술

1) 정의

- 산후에 발생하는 요배통증을 주증으로 하는 것 (산후풍의 범주)

2) 기전

- 호르몬과 Relaxin에 의해 관절 가동성이 증가
- 임신이 진행됨에 따라 요추전만 -> 무게중심 이동
- 체중 증가로 인해 요추에서 부하가 증가
- 복부 근육 저하 -> 후방척추 지지근 긴장도 증가
- 임신 자궁이 커져감에 따라 복부에서 직접 신경자극
- 임신초반기에 골반관절, 치골결합 이완

3) 빈도 / 증상

- 임신 중 약 45%, 분만 후에는 약 25% 여성 요통이나 골반대통증

2. 변증론치

- 허증이 많으므로 養肝腎 위주

간신헌손	요슬산연, 현훈, 목현, 이명, 건망, 수족장열, 건조	
	자보간신	좌귀환, 육미지황탕
혈체경락	찌르는 듯한 요통, 밤에 심함, 오로 자색	
	활혈통락	도인탕
기혈허약	경계, 천급, 면백, 오로 묽음	
	보기양혈	십전대보탕, 팔진탕

풍한침습	사지형한, 면색창백, 찬 것 싫어함	
	온경산한통락	오적산

제 8장 산후 기력진액병증

1절 산후 혈훈

1. 개술

정의	- 분만 직후에 산모가 갑자기 어지럽고 눈앞이 아른거리며 앉아있거나 일어설 수 없으며, 가슴이 그득하고 답답하며 오심과 구토가 있고 담통기급(痰痛氣急), 심번불안하고 심하면 신훈구금(神昏口噤)하며 인사불성하는 증상 - 출혈이 분만 후 24시간 내 일어나는 조기(즉시) 산후 출혈 ※ 產後三衝 증상으로 나타남	
기전	- 산후 출혈, 양수색전, 미만성 혈관내 응고병증(DIC) - 기혈허탈, 어혈정제	
병인병기	- 허탈(虛脫)과 실폐(實閉) 2가지로 분류 - 산후에 실혈이 과다하여 혈허기탈, 어혈이 저체하여 기폐	
진단	임상증상	- 발병시간은 분만 후 수 시간 내에 돌연히 혼결 - 산후 대출혈이 있거나 오로의 이상이

		있거나 혹은 의식이 맑지 않은 것을 위 주로 한 전신증상
	검사소견	- 수축이 충분히 잘 되는데도 불구하고 선홍색의 출혈이 계속되며 대부분 열상
	감별진단	- 산후중서, 산후울모, 전간, 산후경증
예후 & 조리	- 실혈과다로 발생하는 산후 혈훈은 출혈성 shock와 증상이 유사	
	- 모성 사망은 드물지만 치료여건이 좋지 않으면 가 능 ※ 합병증 : 산후감염, 빈혈, 수혈에 의한 감염 Sheehan증후군(유즙분비X), Asherman 증후군	

2. 변증론치

혈허기탈(허)	정신훈란, 현훈, 창백, 경계, 의식소실	
	익기고탈	독삼탕, 생맥산, 補氣解暈湯
어조기폐(실)	아랫배에 짙은 간격의 주기적 통증, 경계, 천급, 면색 암자색, 의식소실	
	활혈화어	탈명산 습 불수산, 가미생화탕

산후 출혈

- ① 특징: 산과적 출혈 중 가장 흔함, 모성사망의 1/4
- ② 정의: 출산 후 24시간 동안 500mL 이상의 출혈
(50%에서 500mL이상의 출혈이 발생)
- ③ 원인: 이완성 자궁출혈 (90%), 자궁경관·질·회음부열상(6%),
태반(편)잔류(3%)
- ④ 위험요인: 자궁이 큰 다태, 양수과다증, 거대아, 다산부 난산 및 자

궁수축제의 과다사용, 산후 출혈 기왕력, 전치태반, 이상유착태반, 태반
조기 박리, 연장된 진통, 전신마취, 임신성 고혈압

⑤ 분류

- 조기(즉시) 산후출혈 : 분만 후 24시간 이내에 발생
- 만기(지연) 산후출혈 : 분만 후 24시간 - 6주 사이에 발생

2절 산후 허로, 욕로

1. 개술

정의	- 산후에 한열왕래, 자한, 두통, 지절동통, 음식不消, 지 체권태, 허리(虛羸), 골증조열, 도한, 면황, 위황, 해수 기촉(咳嗽氣促) 등의 증상이 나타나는 질환	
병인병기	외감	주로 풍한에 의함
	내인	허 - 산후 노력과도, 음식기거실상으로 기혈구허 실 - 정식상위, 간비율노, 약물, 어혈미진

2. 변증치료

기허	창백, 피로, 소언, 천급, 무력, 오한발열, 식욕부진	
	건비보폐익기	보폐탕, 삼령백출산, 육군자탕
혈허	경계, 선경, 다몽, 불면, 건망, 현훈, 이명, 피부건조	
	보혈양간 냉심안신	보간탕, 귀비탕, 가미소요산
기혈양허	창백, 현훈, 소언, 무력, 식은땀, 경계, 불면	
	보기양혈	팔진탕, 십전대보탕
음허	인후건조, 도한, 미열, 요슬산연, 건해, 객혈, 가래, 화를 잘 냄, 열감, 불면, 다몽	
	보익폐신 자음강화	대조환, 자음강화탕,

		백합고금탕, 청리자감탕
양허	피로, 무력, 사지냉, 소화불능, 요슬산연	
	온보비신	증양이로탕, 신기환

3절 산후 자한, 도한

1. 개술

- 산후에 가장 주의, 조절해야 하는 증상 (산후삼급 중 하나)

정의	산후자한	- 산후에 산모가 땀을 비오듯이 흘리는데 그것이 계속되는 경우 - 움직이지 않아도 한출불지하며 움직이면 더욱 심해짐
	산후도한	- 수면 중 땀을 많이 흘려 옷을 적시고 깨면 그치는 경우
병인병기	- 산후에 亡血傷飲하고 元氣耗散 - 氣虛하면 衛陽 부족하고 表虛하여 自汗이 발생 - 傷血하면 음허내열하여 浮陽하고 수렴하지 못함	

2. 변증치료

기허	두한, 오통, 창백, 천급, 소언, 피로	
	보기고표 화영지한 좌이양혈	황기탕, 마황근탕
음허	면적, 현훈이명, 인후건조, 오심번열, 요슬산연, 무력	
	익기양음 생진령한	생맥산

- 한출이 과다하면 망양, 허탈할 수 있으니 치료에 주의
- 마황근, 부소맥, 나도근, 오미자, 오매, 모려 등을 가미해 지한작용 증가

- 변증할 때 한출되는 시간에 따라 자한과 도한을 나누는 외에도 겸증과 설맥을 보고 판단함
- 기허형은 평소 체질이 허약한데 다시 분만 시 기허가 더욱 심해져서 나타나는 것으로, 산후에 땀이 비오듯 흐르는데 이것이 지속되고 그치지 않으며 움직이면 더 심한 증상이 나타남
- 음허형은 평소 음혈이 부족한데 분만 시 실혈로 더욱 심해져서 나타나는 것으로, 산후 수면 중에 한출하고 심하면 목욕한 듯 옷이 젖지만 깨면 저절로 멎는 증상이 나타남

4절 산후부종

1. 개술

정의	- 두면이나 지체에 부종이 발생하거나 산전부종이 소실되지 않는 경우
병인병기	- 脾虛, 腎虛, 血虛氣滯, 敗血流注로 발생 - 산후에 기혈이 허약한 상태에서 패혈이 오장에 정체, 경락을 따라 사지로 유입하여 발생 → 활혈하여 치료
진단	- 부종은 간질액의 용적이 과량 증가하여 체중이 수 kg 정도 증가하여 체중의 일중변화를 동반 - 체성분 분석기 상의 부종지수가 0.35 이상인 경우
예후	- 산전에 태아가 점차 커짐으로 인해 기혈이 조체하여 부종있는 경우 산후에 일반적으로 점차 소실 - 산후 기혈노상으로 부종이 발생하였는데 조리를 잘못한 경우 -> 培補氣血劑를 가미하면 쉽게 소실

2. 변증치료

비허	피부팽창, 광택, 식욕부진, 피로, 소변少	
	건비이수	사군자탕, 이수익기탕
신허	요슬산연, 하지무력, 해수, 천급	
	온보신약 화기행수	신기환
혈허기체	현훈, 목현, 면색담황, 식욕부진, 흉완창만	
	익혈리기 행체리수	소조중탕
패혈유주	눈꺼풀과 눈두덩에 부종, 누르면 팽팽하고 아픔	
	화혈화어 온경통락	소조경산

- 혈허기체는 평소 허약하거나 분만할 때 상혈모기 등으로 인해 혈행이 부족한 경우 나타나는 것으로, 부종의 상태가 심하기보다는 오로의 양이 적고 색이 꺼멓다.

제 9장 산후 유즙 및 유방 관련 병증

1절 산후 유방관리와 유방 관련 증상의 개술

유방울혈	정의	- 유선분비 시작 후 1~2일 동안 유방은 딱딱해지고 팽창되어 심할 때는 액와부까지 통증이 있으면서 일시적으로 37.8~37.9도 발열
	원인	- 정맥, 림프선의 울혈 (정상적 유즙분비의 전조)
	처치	- 브래지어, 유방대, 유즙짜기, 얼음찜질, 진통제
유즙분비 억제	- 잘 맞는 유방대, 냉찜질, 진통제 이용, 호르몬요법 - 유즙을 짜는 자극을 하지 않으면 수일 내 소실	
유방염	- -화농성 유선염은 분만 후 1주 이전에는 거의 발생 X - 감염은 주로 편측에 오고 염증에 선행하여 현저한 유방울혈, 유방 오한이 난 후 체온 및 맥박의 상성을 보이며, 유방은 딱딱해져 통증 호소	
유두 이상	① 함몰유두: 심하지 않으면 짜내는 방법으로 수유 가능 ② 역유두: 임신 말기에 유두가 밖으로 나오게 매일 손으로 견인하거나 전동식 펌프를 이용 ③ 유두열구: 수유 시 쉽게 손상되고 통증 느껴	

	분비작용도 지장, 빨리 치유해야 함
분비 이상	- 대개 분만 3~4일 후 소량의 유즙이 분비되기 시작 - 유즙 분비 양: 대개 600cc 넘으면 정상

2절 결유

1. 개술

정의	- 산후에 유즙분비가 없거나 있더라도 매우 적어 영아의 젖 요구량을 충족시키지 못하는 경우 ※ 산후 2~3일부터 15일 이내 많이 발생 ※ 정상: 일반적으로 산모는 하루에 약 700~750cc를 사용, 영아를 하루에 80~85cc씩 8회 정도 수유	
병인병기	- 유방은 陽明胃經에 속하고, 유두는 厥陰肝經에 속함 - 유즙은 氣血化生으로 생기지만 그 내원은 중초 비위에 있음 - 유즙분비는 유선의 발육과 태반기능, 전신상태와 밀접한 체액성 기전과 신경성 기전의 복합적 관여 - 스트레스 보다는 기혈허로 인한 결유가 많음	
진단	허증	유방이 유연, 불창불통, 누르면 유즙 방울짐
	실증	유방창만, 유선에 괴가 형성, 누르면 아프고 잘 나오지 않음
	감별	유옹 (결유는 국소피부 변화 X)

2. 변증치료

기혈허약	유즙 생화부족 -> 유방 유연, 유즙청희, 면색소태	
	보기양혈 증액통락	통유단 저제탕
간울기체	유즙 배출장애 -> 유방 팽팽하고 단단, 통통, 흉협창만	
	소간해울 통락하유	소요산 하유통천산

- 가미사물탕이 유의하게 모유량을 증가시킨다는 연구결과 존재함

3절 산후 유즙자출

1. 개술

정의	- 산후나 수유기 중에 영아가 빨지 않아도 유즙이 저절로 나오는 경우
생리	①氣血이 충족하여 유방이 가득차서 유출 ②수유기에 아직 수유를 하지 않아서 유출 ③수유를 중단할 때가 되었는데 끊이지 않는 것
병인병기	-氣虛로 固攝하지 못하거나, 肝火熾盛으로 유즙 外溢

2. 변증치료

기혈허약	유즙량 적고 몹으며 유방 유연	
	보기양혈	고섭렴유
간경울열	유즙 적고 농조하며 유방창통	
	소간해울 청열렴유	단치소요산

3. 회유 = 유즙을 말리는 것

- 유즙이 많지 않은 산모는 수유의 횟수를 감소시키는 것만으로도 유즙

분비 감소

- 약물회유: 맥아전(麥芽煎) / 면회탕(免懷湯)
- 외치법: 朴硝를 외포
- 침치법: 광명, 족임읍

4절 유옹 = 유선염

1. 개술

정의	- 유방이 옹종농양하는 질환	
(발병시기별) 분류	外吹乳癰	산후 1개월 이내, 수유기에 유즙축적으로 발생
	內吹乳癰	임신 말기, 태기왕성으로 상충해 발생
	非授乳期乳癰	남녀노소 불문, 간기울체가 乳絡阻塞
병인병기	- 주된 원인은 肝鬱, 胃熱, 感染邪毒으로 인한 유즙축적 - 축적된 유즙이 위열이나 외감지사와 상박해 熱盛肉腐 - 주된 원인균은 포도상구균	
진단	외취유옹	- 산후 1개월이 지나지 않은 초산부에 다발 - 초기에 적절한 치료를 시행하면 消散 - 치료 안하고, 경괴가 점차 연해지면 농 성숙 단계
	내취유옹	- 임신 말기의 임신부에게 다발

		- 외취유옹에 비해 진행이 느리고 瘡口 수렴 어렵
	검사법	WBC 증가, 발열, 압통, 결절, 파동성 확인, 유방초음파

2. 변증치료

외취유옹	간울위열	갑자기 수유 중단하여 유방 붓고 단단해지고 아픔, 피부 X	
		소간청위 통유산결	과루우방자탕 가미지패산
	열독내성	유방종괴 증대, 경결 뚜렷해짐, 피부 붉어짐	
		탁리투농	탁리소독산 선방활명음
내취유옹	임신 6~7개월이나 8~9개월에 많음, 발열 동반		
	소간청위 안태	소요산 가감	